NOTA TÉCNICA

MPOX

2026

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Governador do Estado do Ceará
Elmano de Freitas da Costa

Secretária da Saúde do Ceará
Tânia Mara Silva Coelho

Secretário Executivo de Vigilância em Saúde
Antonio Silva Lima Neto

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Ana Maria Peixoto Cabral Maia

Célula de Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Transmissíveis e não Transmissíveis
Carlos Garcia Filho

Coordenadoria de Imunização
Ana Karine Borges Carneiro

Laboratório Central de Saúde Pública
Ítalo José Mesquita Cavalcante

Elaboração e revisão
Ana Karine Borges Carneiro
Ana Neta Alves
Anderson Leonardo Silva de Sales
Anuzia Lopes Saunders
Camila Freitas Andrade
Caroline Oliveira da Fonseca
Danielle Martins Rabelo Gurgel
Eloilson Carneiro do Nascimento
Evelly Caroline Botelho de Miranda
Kamilla Carneiro Alves Marques
Karene Ferreira Cavalcante
Léa Maria Moura Barroso Diógenes
Maria Mayara de Aguiar Sales
Maria Vilani de Matos
Telma Alves Martins
Vânia Angélica Feitosa Viana
Maria Elisabeth Lisboa de Melo
Maria Gabriela Rodrigues da Costa
Vitória Carla Carvalho
Igor Moreira de Almeida
Yara Saldanha Freitas

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (SEVIG) apresenta esta Nota Técnica com o objetivo de atualizar as orientações para vigilância, prevenção e controle da mpox.

Trata-se de uma **atualização da Nota Técnica Nº 05 de 05 de julho de 2022,** com base nas recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Embora o número de casos novos tenha diminuído significativamente em relação ao surto global em 2022, a persistência da transmissão reforça a necessidade de vigilância contínua e monitoramento ativo dos casos, especialmente com a emergência de novas variantes, como o clado Ib na República Democrática do Congo, considerado uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

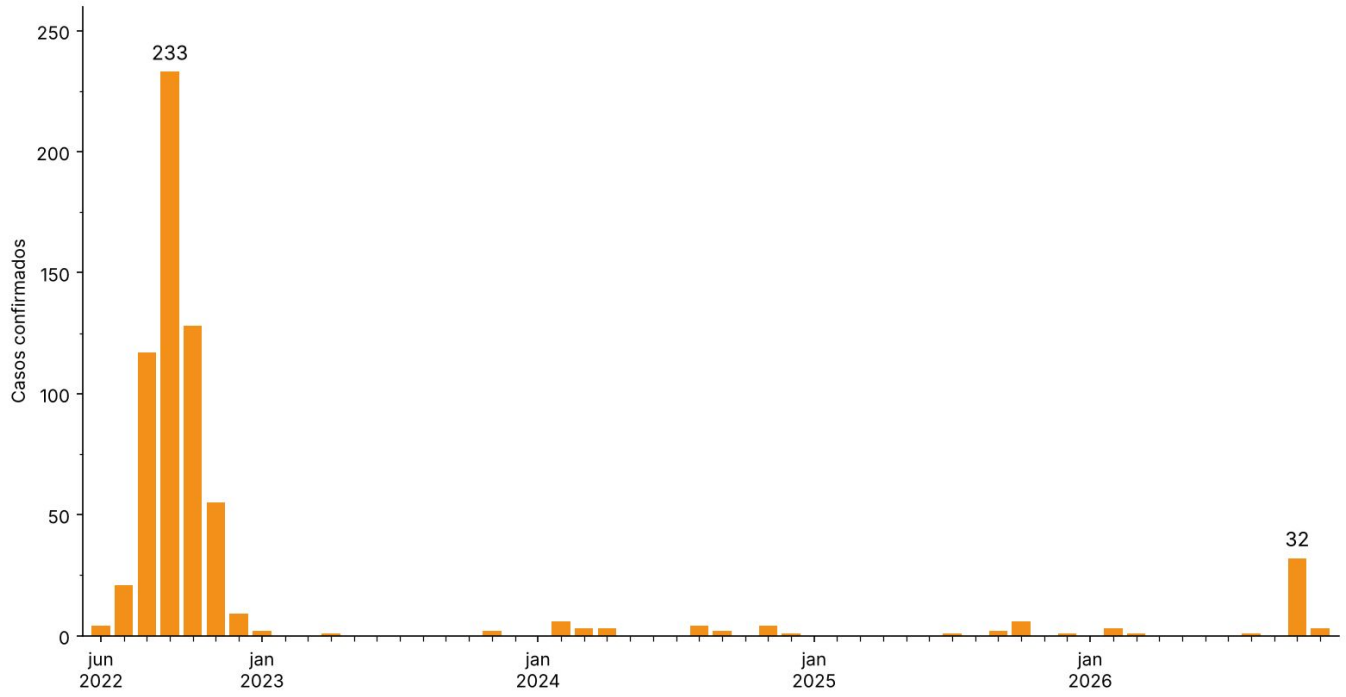
Nesse contexto, a SESA Ceará reforça a importância da detecção oportuna de casos suspeitos, da notificação e das estratégias de controle da doença visando promover uma resposta eficaz e reduzir seus impactos na população.

1. CONTEXTO

1.1 Cenário epidemiológico

No Ceará, as primeiras notificações de casos suspeitos de mpox ocorreram em maio de 2022. Até junho daquele ano, haviam sido registrados 14 casos notificados, dos quais um (01) foi confirmado, em um homem de 35 anos residente em Fortaleza. Nos meses seguintes, houve aumento do número de casos, totalizando 567 confirmações entre 1.963 notificações em 2022. O maior número de casos confirmados por mês de início dos sintomas foi registrado em setembro, com 233 casos (Gráfico 1). Nos anos seguintes, houve menos registros de casos do que o observado em 2022, com oito casos confirmados em 2023, 25 em 2024 e 13 em 2025. Em 2026, observou-se aumento do número de casos com início dos sintomas em outubro, totalizando 40 casos 2026 confirmados.

Gráfico 1. Casos confirmados de mpox por mês de início dos sintomas, Ceará, junho de 2022 a novembro de 2026*



Fonte: IntegraSUS/SESA, consultado em 06/11/2026 (2022 a 2025); e-SUS Sinan, exportação de 05/11/2026 (2026). *Dados de 2026 até 05/11/2026, sujeitos a alteração.

1.2 Cenário atual (2026)

Em 2026, até 05/11/2026, 113 pessoas residentes no Ceará foram notificadas com suspeita de mpox. Destas, 40 (35,4%) tiveram o diagnóstico confirmado por exame laboratorial, 60 foram descartadas, 1 foi encerrada como caso provável e 12 seguem em investigação.

Os casos se concentram em outubro e novembro: 18 confirmados foram notificados em outubro e 17 em novembro, contra 5 de janeiro a setembro. Todos os confirmados são do sexo masculino, com idade entre 24 e 51 anos; 35 (87,5%) residem em Fortaleza. Dois foram internados por necessidade clínica e não houve óbito. Ademais há um caso de pessoa do sexo feminino encerrado como provável por critério clínico-epidemiológico.

Amostras de um dos pacientes, analisadas pelo laboratório de referência (Fiocruz, Instituto Oswaldo Cruz), tiveram resultado liberado em 04/11/2026, com identificação do clado II. Para os demais casos, o clado ainda não foi informado.

Mais informações sobre o cenário epidemiológico da mpox no Ceará podem ser consultadas no painel de monitoramento do IntegraSUS.

Nota: Os dados do painel são atualizados periodicamente e podem divergir dos apresentados nesta nota técnica, conforme a data de atualização.



2. CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA

2.1 Etiologia

A mpox (anteriormente conhecida por Monkeypox) é causada pelo Mpox vírus (MPXV), pertencente ao gênero *Orthopoxvirus*. É uma doença zoonótica e endêmica em alguns países da África central e Ocidental, onde ocorrem surtos esporádicos entre humanos.

2.2 Transmissão

O período de incubação varia de 6 a 16 dias, podendo estender-se até 21 dias, todavia a transmissibilidade ocorre desde o início dos sintomas até a cicatrização completa das lesões. A mpox pode ser transmitida de animais para humanos e entre humanos. A transmissão entre humanos ocorre por contato direto com lesões na pele ou mucosas, secreções respiratórias (gotículas), fluidos corporais ou por superfícies e objetos contaminados (roupas de cama, toalhas e utensílios). A transmissão de pessoa a pessoa exige contato próximo e prolongado, especialmente em situações de contato pele-a-pele, mucosa-a-mucosa, ou lesões de pele. A transmissão sexual também tem sido observada.

2.3 Manifestações Clínicas

No período prodrômico (1 a 5 dias) os sintomas podem ou não estar presentes, e quando aparecem está caracterizado pelo surgimento de febre, cefaleia, mialgia, adenomegalia e astenia. No período clínico surgem as erupções cutâneas que evoluem de máculas para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Essas lesões podem aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo a face, tronco, genitais e extremidades. Casos graves podem envolver complicações como infecções bacterianas secundárias, sepse, encefalite ou pneumonia. A maioria dos casos é autolimitada, com recuperação total em 2 a 4 semanas. O prognóstico é geralmente bom. O índice de mortalidade é baixo.

2.4 Diagnóstico

O diagnóstico é confirmado pela detecção molecular do vírus através do PCR em tempo real. Amostras de lesões cutâneas ou crostas são os principais materiais utilizados. O diagnóstico diferencial deve incluir varicela, herpes zoster, sífilis, entre outras condições com erupções cutâneas. Em casos de suspeita clínica recomenda-se a testagem para HIV e outras ISTs.

2.5 Tratamento

A conduta em casos leves envolve analgesia quando necessário e vigilância de sinais e sintomas de gravidade, sendo estas as principais condutas. Pessoas pertencentes aos grupos com maior risco para evolução da doença (gestante, idosos e pessoas vivendo com HIV/aids com contagem baixa de LT-CD4 <= 200 ml/mm^3) devem ser avaliadas quanto a gravidade e necessidade de hospitalização. Infecções bacterianas secundárias devem ser tratadas com antibióticos apropriados

2.6 Prevenção

As principais medidas de prevenção envolvem evitar o contato direto com lesões cutâneas, fluidos corporais e objetos contaminados de pessoas infectadas. Para profissionais de saúde e cuidadores é essencial o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, avental, máscara cirúrgica e óculos de proteção. Entre as ações, pode-se destacar:

- A **lavagem regular das mãos** com água e sabão ou uso de álcool em gel é uma medida importante para prevenir a disseminação do vírus.
- Os pacientes confirmados ou suspeitos, até a cicatrização completa das lesões e com restrição de contato próximo com outras pessoas, devem permanecer em isolamento.
- Os serviços de saúde devem adotar, além das **medidas de precaução** padrão, medidas para contato e gotículas.
- Objetos pessoais, roupas de cama e superfícies potencialmente contaminados devem ser **higienizados** com água e detergente. As superfícies devem ser desinfetadas com saneantes regularizados pela Anvisa, observando as recomendações do fabricante quanto à concentração e ao tempo de contato. Roupas e tecidos devem ser lavados separadamente.

3. DEFINIÇÃO DE CASO

3.1 Caso suspeito: Indivíduo de qualquer idade que apresenta início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva de mpox (geralmente, lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central.) única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor ou sangramento anorretal), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.

3.2 Caso provável: Caso que atende à definição de caso suspeito, que apresenta um **OU** mais dos seguintes critérios listados abaixo, com investigação laboratorial de mpox não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico de mpox não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico.

- Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, **OU** contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e/ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; **E/OU**
- Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, **OU** histórico de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; **E/OU**
- Contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes a um caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; **E/OU**
- Trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) com histórico de contato com caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.
- E Investigação laboratorial de mpox não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico de x não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico.

3.4 Caso confirmado: Caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para MPXV por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).

3.5 Casos descartados: Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para MPXV por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento) **OU** sem resultado laboratorial para MPXV E realizado diagnóstico complementar que descarta mpox como a principal hipótese de diagnóstico.

4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.1 Notificação e investigação epidemiológica

A mpox é uma doença de notificação compulsória imediata, conforme a Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017 e suas atualizações. Os casos suspeitos devem ser registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (e-SUS Sinan) em até 24 horas e comunicados à vigilância epidemiológica municipal.

A investigação epidemiológica deve ser iniciada na suspeita, com identificação de possíveis fontes de infecção, histórico de exposição e vínculos epidemiológicos. Os casos devem ser acompanhados até sua confirmação ou descarte, com atualização das informações no sistema.

4.2 Investigação epidemiológica complementar

Os casos suspeitos de mpox devem ser acompanhados pela vigilância epidemiológica municipal até sua confirmação ou descarte, com atualização das informações no e-SUS Sinan. Para os casos confirmados, recomenda-se a aplicação da **Ficha de Investigação Epidemiológica Complementar**, com o objetivo de aprofundar as informações sobre possíveis exposições, vínculos epidemiológicos e cadeias de transmissão, além de orientar o rastreamento e monitoramento dos contatos por **21 dias após a última exposição**. A aplicação da ficha deverá considerar a capacidade operacional dos serviços de vigilância, com prioridade para casos graves, óbitos e agrupamentos de casos.

A **Ficha de Investigação Epidemiológica Complementar de Caso de Mpox** está disponível nas versões: WORD e PDF**,**

4.3 Rastreamento e monitoramento de contatos

Considera-se contato a pessoa que, nos últimos 21 dias, teve uma ou mais das seguintes exposições a caso suspeito, provável ou confirmado de mpox:

- Contato físico direto, incluindo contato sexual;
- Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória adequada;
- Contato com materiais potencialmente contaminados, como roupas de cama, toalhas e objetos pessoais;
- Exposição ocupacional sem utilização adequada de equipamentos de proteção individual (EPI).

O monitoramento dos contatos deve ser iniciado ainda na fase de suspeita, com acompanhamento a cada 24 horas para identificação de sinais e sintomas. Recomenda-se aferição da temperatura duas vezes ao dia e comunicação imediata à equipe de saúde diante do surgimento de sintomas.

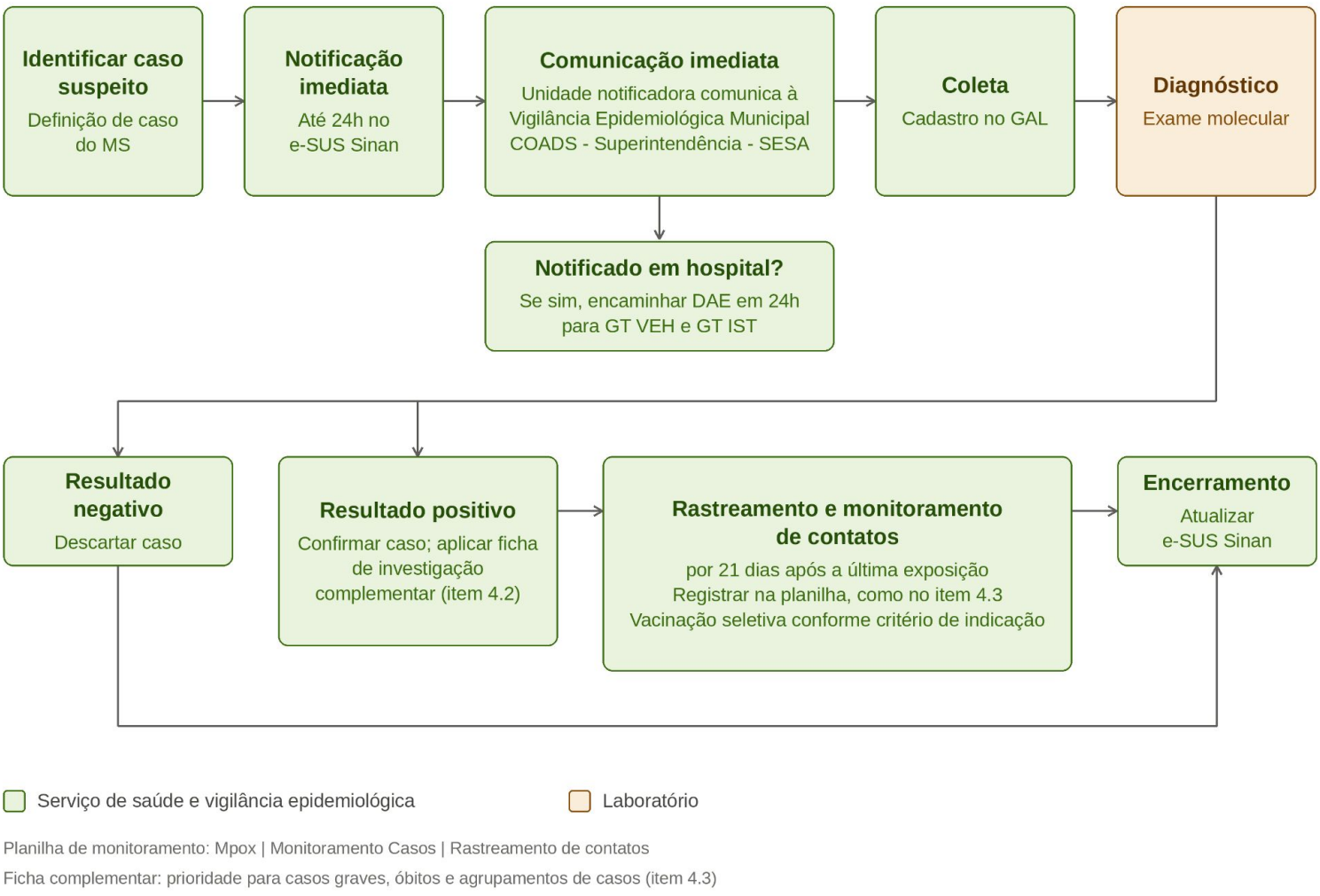
Nos **casos confirmados**, o monitoramento deve ser mantido por **21 dias após a última exposição**. Em caso de resultado laboratorial negativo, a continuidade deverá ser reavaliada conforme os critérios de descarte.

Para apoiar o registro e o acompanhamento dos contatos, disponibiliza-se um MODELO DE PLANILHA DE MONITORAMENTO disponível para download. Cada município poderá baixar uma cópia e utilizá-la para organizar e atualizar seu próprio banco de dados, assegurando a confidencialidade das informações.

Contatos assintomáticos **não** necessitam de isolamento. Na presença de sintomas sugestivos, deve-se realizar avaliação clínica e seguir o fluxo de investigação de casos suspeitos. Gestantes, crianças menores de 8 anos e pessoas imunossuprimidas requerem atenção especial devido ao maior risco de complicações. Caso desenvolvam a doença, o acompanhamento clínico deverá ser mantido até a resolução dos sintomas e a cicatrização completa das lesões.

Nota de confidencialidade: As informações registradas são de caráter sigiloso e devem ser utilizadas exclusivamente para fins de vigilância epidemiológica, com acesso restrito aos profissionais autorizados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

4.4 Fluxograma de Notificação, Comunicação e Investigação de Casos



5. PLANTÃO EPIDEMIOLÓGICO

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Estadual) disponibiliza Plantão Epidemiológico para assegurar a comunicação oportuna e o acompanhamento de eventos de importância em saúde pública durante finais de semana e feriados.

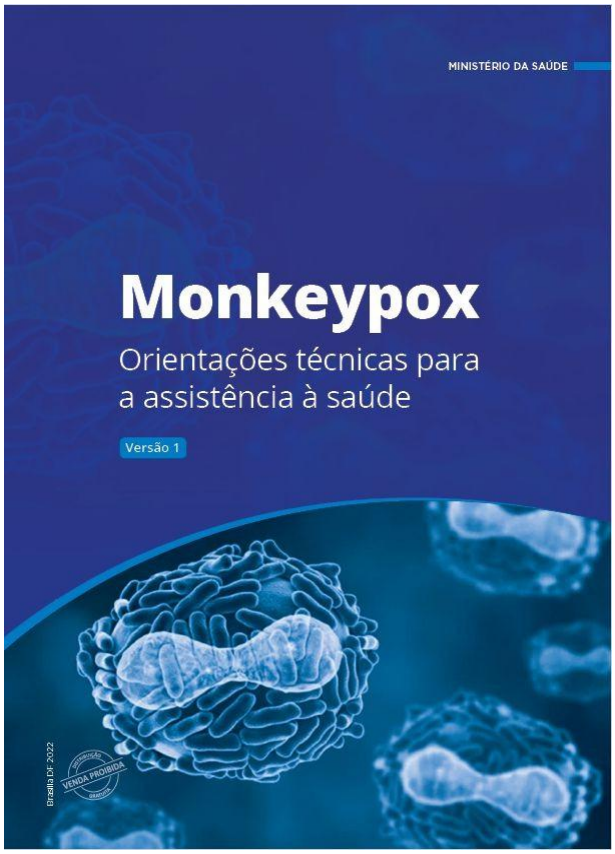
Horário de funcionamento: Finais de semana e feriados, das 8h às 17h

Canais de comunicação: (85) 98724-0455 | cievs.ce@saude.ce.gov.br

6. MANEJO CLÍNICO

Informações detalhadas sobre o manejo clínico da mpox podem ser encontradas em:

MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE - MPOX



6. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

O Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen-CE) realiza o diagnóstico molecular do mpox, método atualmente utilizado para confirmação da doença. O ensaio multiplex de PCR em tempo real (qPCR), permite a detecção do mpox vírus (MPXV) de forma genérica sem distinção entre as cepas, além de permitir a identificação dos vírus Varicella Zóster (VZV) e Orthopoxvirus (OPXV). O exame é indicado para amostras clínicas provenientes de secreção vesicular, crosta e exsudato de lesão.

6.1 Coleta das espécies clínicas - Procedimento operacional

6.1.1 Tipos de amostras

- **Material vesicular (secreção de Vesícula) e Lesões de mucosas (oral/região perianal e genital):** A coleta deve ser realizada na fase aguda da doença, pois é nesse período que se obtém carga viral mais elevada na lesão. A coleta de material de lesões cutâneas ou mucosas deve ser realizada por meio de swab, sendo o método mais indicado para confirmação diagnóstica. Swabs estéreis de nylon, poliéster, Dacron ou Rayon são os indicados. Deve-se realizar esfregaço forte e intenso sobre uma ou mais lesões, dando preferência às lesões vesiculares ou às pústulas. Quando o paciente suspeito apresentar mais de uma vesícula, sugere-se coletar um swab de cada lesão, no mínimo, dois swabs por paciente, e armazená-los em um único frasco sem meio de transporte viral (estéril), formando um pool (conjunto) de amostras do mesmo paciente.
- **Crosta (Crosta de Lesão):** Nos casos em que o paciente apresentar lesões secas, devem ser coletadas, preferencialmente, as crostas menos ressecadas, por estarem em fase inicial de cicatrização e apresentarem maior chance de detecção viral. As crostas devem ser acondicionadas em frasco seco (estéril), sem líquido preservante, fornecido pelo Lacen. Quando o paciente suspeito apresentar mais de uma lesão, sugere-se coletar, se possível, 4 amostras da crosta por paciente, e armazená-las em um único frasco sem meio de transporte viral. Não misturar crostas com amostras de swab de secreção no mesmo frasco.

Observações

Após análise laboratorial no Lacen-CE, as amostras são avaliadas quanto ao valor de Ct (cycle threshold), parâmetro utilizado para estimar a carga viral e orientar a seleção daquelas que serão encaminhadas ao laboratório de referência nacional para tipagem e sequenciamento genômico, visando à identificação das linhagens e dos clados virais.

6.1.2 Acondicionamento e transporte

As amostras deverão ser acondicionadas em caixas térmicas rígidas, refrigeradas com auxilio de baterias de gelo e que mantenham a temperatura entre **4 °C e 8 °C, até a chegada ao LACEN, no prazo máximo de 24 horas.**

6.1.3 Solicitação dos Kits de coleta para MPOX

Para solicitar kits de coleta, as unidades solicitantes deverão preencher o formulário disponível no link abaixo, informando os dados necessários para a identificação da unidade e o quantitativo de kits necessários.

- Link para solicitação de kits: SOLICITAÇÃO DE KITS

6.1.4 Documentação obrigatória

As amostras deverão ser encaminhadas acompanhadas da ficha de notificação do SINAN e do formulário de solicitação de exame, devidamente preenchidos. O formulário de Solicitação corresponde ao FOR.545.011, está disponível no link abaixo. É indispensável que a documentação esteja completa, com informações compatíveis com a amostra encaminhada e o devido preenchimento dos dados clínicos e epidemiológicos relevantes sobre o paciente suspeito, como histórico de viagens, situação vacinal, ocupação, entre outros aspectos que possam contribuir para a investigação epidemiológica e laboratorial.

- Link para acesso ao formulário FOR.545.011: FORMULÁRIOS GAL

6.1.5 Cadastro no Gerenciador de Ambiente Laboratorial

O cadastro no sistema GAL deve corresponder ao material coletado. Recomenda-se a coleta de secreção de vesícula e crosta de lesão, com o registro de ambos os tipos de amostra no sistema.

Finalidade: Investigação;
Descrição: Monkeypox vírus;
Agravo/Doença: Varíola;
Nova amostra (material): Secreção de vesícula e/ou Crosta de lesão;

Pesquisa a ser cadastrada:
Monkeypox vírus – secreção de vesícula;
Monkeypox vírus – crosta
Metodologia: qPCR

7. IMUNIZAÇÃO

Mediante a Nota Técnica Conjunta nº 403/2026-DPNI/SVSA/MS, o Ministério da Saúde atualiza as orientações sobre a estratégia de vacinação contra a mpox, considerando novas evidências científicas e o cenário epidemiológico observado em 2026.

Ressaltamos que, entre 2023 e 2025, o Ceará realizou a vacinação no esquema de pré-exposição. Como não há recomendação de vacinação em massa e a vacina contra a mpox não integra o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a estratégia foi encerrada após o esgotamento dos estoques disponíveis em âmbito nacional.

Entretanto, diante do aumento de casos confirmados ou prováveis nos estados do Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, entre as semanas epidemiológicas (SE) 41 e 45 de 2026, o Ministério da Saúde orienta a retomada da estratégia de vacinação, condicionada à disponibilidade de doses no estoque nacional.

Nesse contexto, a estratégia passa a incorporar uma atualização na via de administração da vacina, com a adoção da via intradérmica, utilizando um volume reduzido de 0,1 mL por dose. Essa mudança possibilita otimizar o aproveitamento das doses disponíveis, ampliar a oferta de vacinação e favorecer o acesso dos públicos contemplados pela estratégia.

7.1 Indicação

Diante do aumento expressivo de casos, a vacina está indicada prioritariamente para esquema de **pós-exposição**, podendo ser realizada, excepcionalmente, a estratégia de pré-exposição conforme critérios de elegibilidade definidos pelo MS.

- **Pós-exposição:** Pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de Mpox.

Local de atendimento: Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio da avaliação das equipes de Vigilância Epidemiológica, de acordo com a **Ficha de Investigação Epidemiológica Complementar**.

A vacinação não será realizada em massa nem fará parte da rotina dos postos de saúde. A oferta será seletiva, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e a disponibilidade de doses.

7. IMUNIZAÇÃO

7.1 Indicação (cont.)

Definição do risco de exposição:

- Alto risco: contato físico direto, incluindo contato sexual, pele a pele ou boca a pele; contato com lesões, secreções e fluidos corporais; exposição de mucosas a respingos; compartilhamento de residência com pessoa diagnosticada ou contato com materiais contaminados, sem proteção adequada.
- Médio risco: permanência próxima, no mesmo ambiente fechado, com pessoa sintomática com Mpox confirmada, sem utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados.

Período após exposição: preferencialmente até **04 dias** após a exposição, para maior efetividade na prevenção da infecção. A vacinação também poderá ser realizada até **14 dias** da exposição, no entanto, nesta situação, espera-se que a efetividade da vacina para prevenção da infecção seja reduzida, de tal forma que o objetivo da vacinação será de reduzir o risco de progressão para formas graves.

Importante destacar que, em nível individual, a vacinação não deve substituir as demais medidas de proteção recomendadas.

- **Pré-exposição:** Pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células/mm³, a partir de 18 anos de idade.

Local de atendimento: Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio da Rede de Imunobiológicos Especiais (RIE). Inicialmente, o usuário deverá apresentar a documentação comprobatória da indicação para vacinação (laudo médico, prescrição ou outros documentos pertinentes), que será encaminhada via email para a unidade do CRIE de abrangência. Após a análise e validação da documentação, a vacina será enviada (seguindo a cadeia de frio) e portanto será realizado o agendamento da vacinação entre UBS e usuário.

Nota: A depender da disponibilidade de doses e do prazo de utilização após o descongelamento, a estratégia poderá ser ampliada, mediante articulação e alinhamento entre as diferentes esferas de gestão. Ver nota técnica 403/2026.

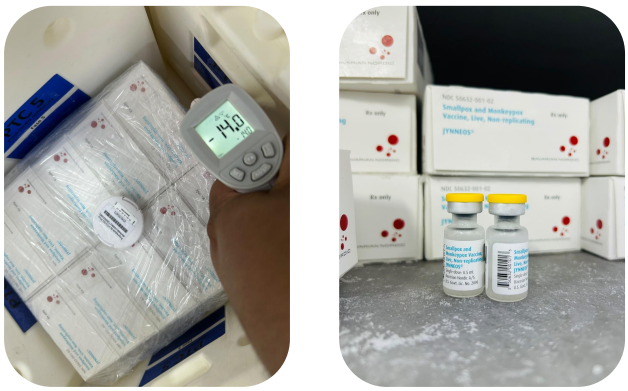
7. IMUNIZAÇÃO

7.2 Características da vacina

- A Jynneos (Vacina Varíola Símia atenuada) é uma vacina viva, produzida pela Bavarian Nordic a partir da cepa Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) modificada, um Orthopoxvírus atenuado e não replicante contra varíola e varíola de macaco, que induz respostas imunes humorais e celulares aos Orthopoxvírus.
- Apresentação: monodose (0,5ml/frasco);
- Conservação: Congelada entre - 25 °C e - 15 °C. Uma vez descongelada, a vacina deve ser mantida a + 2 °C a + 8 °C, por até 4 semanas.
- Para administração por via intradérmica (volume 0,1 ml), após abertura de frasco, a vacina deve ser utilizada em até 8 horas.

Atenção: Cuidado para a data do descongelamento, assim como a data da abertura do frasco nos casos de administração por via intradérmica. Não usar a vacina após a validade.

Figura 1. Vacina Jynneos



Fonte: Ceará, 2026.

7.3 Dose, esquema e via de administração

- **0,1 mL - Via intradérmica (ID) - 02 doses (intervalo de 28 dias entre doses)**

Indicação: adultos elegíveis (no esquema de pré e pós exposição ao mpox)

- **0,5 mL - Via subcutânea (SC) - 02 doses (intervalo de 28 dias entre doses)**

Indicação: pessoas com HIV, independentemente do estado imunológico, ou com imunodeficiências congênitas ou adquiridas, incluindo aquelas em uso de medicamentos imunossupressores (no esquema de pré e pós exposição ao mpox)

7.4 Contraindicações

- Histórico de reação alérgica grave (ex.: anafilaxia) após a administração de uma dose prévia da vacina.
- Não devem ser vacinados pessoas que já tenham sido previamente diagnosticados com mpox e/ou que apresentem lesões de pele compatíveis com diagnóstico clínico da doença no momento do atendimento.

Na vacinação pré-exposição, recomenda-se um intervalo de 30 (trinta) dias com qualquer vacina previamente administrada. Em situação de pós-exposição, cujo principal objetivo é bloqueio da transmissão, recomenda-se que a vacinação contra a mpox seja realizada, independente da administração prévia de qualquer imunobiológico.

7.5 Precauções

- História de reação alérgica grave após o uso de gentamicina ou ciprofloxacino; OU • História de reação alérgica grave a proteína do ovo ou da galinha - avaliação individualizada de risco vs benefício
- Gestantes e lactantes - avaliação individualizada de risco vs benefício
- Doenças febris agudas Indivíduos com quadros leves como resfriados comuns poderão ser vacinados - idealmente aguardar a recuperação para realizar a vacinação.

7.6 Notificação de ESAVI

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da suspeita de ESAVI, incluindo erros de imunizações (programáticos ou operacionais, tais como problemas na cadeia de frio, erros de preparação da dose ou erros na via de administração, dentre outros), deverão notificá-los às autoridades de saúde.

7.7 Registro dos vacinados

O registro deve garantir a identificação do vacinado pelo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), além da identificação da vacina, lote, via de administração, fabricante, estratégia e dose aplicada.

- Sistema de informação: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), e-SUS APS ou sistema integrado com a RNDS;
- Estratégia: Intensificação (Pré-exposição) ou Bloqueio (Pós-exposição);
- Via de administração: SC ou ID
- Dose: D1 ou D2.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Portaria GM/MS Nº 1.102, DE 13 DE MAIO DE 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Monkeypox: orientações técnicas para a assistência à saúde. Versão 1. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/mpox/protocolos/mpox-orientacoes-tecnicas-para-a-assistencia-a-saude/view. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL, Ministério da Saúde. Informe Técnico Operacional de Vacinação contra a Mpox. Brasília, 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 13/2023-CGCI/DIMU/SVSA/MS. Atualização do Informe Técnico Operacional de Vacinação contra a Mpox. Brasília, 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica n°29/2024.Recomendação para intensificação da vigilância de casos de Mpox, Brasília, 2024.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica conjunta nº 3/2025-DATHI/DPNI/CGLAB/SVSA/MS. Recomendações e orientações sobre o diagnóstico de Mpox no território nacional, em relação ao fluxo de vigilância laboratorial e atualização da estratégia de operacionalização da vacinação. Brasília, 2025.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 26/2025-/DPNI/SVSA/MS. Orientações para registros de doses aplicadas da vacina contra variola símia (atenuada) anteriormente chamada de Varíola Bavarian Nordic (vacina Mpox). Brasília, 2025.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica conjunta nº 403/2026-DPNI/SVSA/MS. Atualizações sobre a estratégia de vacinação contra a mpox, com base em novas evidências científicas e diante do cenário epidemiológico . Brasília, 2026.

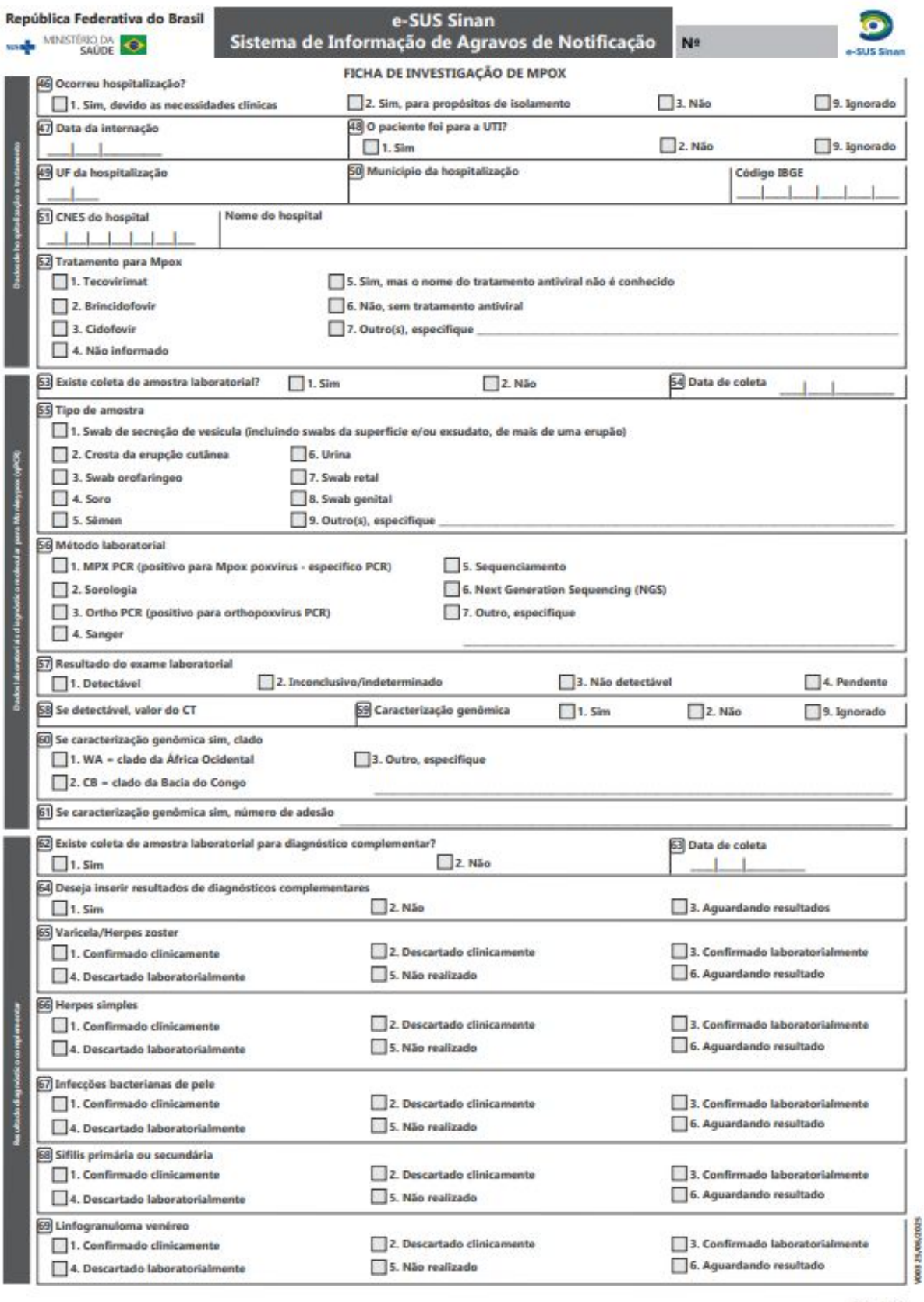
CEARÁ. Informe operacional vacinação, 2023. https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/INFORME-OPERACIONAL-MPOX.pptx-1.pdf

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Alerta Epidemiológico - mpox (MPXV clado I), 8 de agosto de 2024 Washington, D.C.: OPAS/OMS; 2024. Disponível em: https://www.paho.org/pt/documentos/alertaepidemiologico-Mpox-mpxv-clado-i-8-agosto-2024

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Fifth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the upsurge of mpox 2024**. Geneva: WHO, 30 out. 2025. Disponível em: https://www.who.int/news/item/30-10-2025-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024. Acesso em: 6 nov. 2026.

ANEXO - Ficha de notificação de mpox

link de acesso: [FICHA E-SUS]



República Federativa do Brasil
MINISTÉRIO DA SAÚDE

e-SUS Sinan
Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Nº

e-SUS Sinan

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE MPOX

Dados de hospitalização e tratamento

46 Ocorreu hospitalização?
☐ 1. Sim, devido as necessidades clínicas ☐ 2. Sim, para propósitos de isolamento ☐ 3. Não ☐ 9. Ignorado

47 Data da internação __/__/____

48 O paciente foi para a UTI?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 9. Ignorado

49 UF da hospitalização __

50 Município da hospitalização

Código IBGE

51 CNES do hospital

Nome do hospital

52 Tratamento para Mpox
☐ 1. Tecovirimat
☐ 2. Brincidofovir
☐ 3. Cidofovir
☐ 4. Não informado
☐ 5. Sim, mas o nome do tratamento antiviral não é conhecido
☐ 6. Não, sem tratamento antiviral
☐ 7. Outro(s), especifique

Dados laboratoriais de diagnóstico e ordenar para Monkeypox (MPOX)

53 Existe coleta de amostra laboratorial? ☐ 1. Sim ☐ 2. Não

54 Data de coleta __/__/____

55 Tipo de amostra
☐ 1. Swab de secreção de vesícula (incluindo swabs da superfície e/ou exsudato, de mais de uma erupão)
☐ 2. Crosta da erupção cutânea
☐ 3. Swab orofaríngeo
☐ 4. Soro
☐ 5. Sêmen
☐ 6. Urina
☐ 7. Swab retal
☐ 8. Swab genital
☐ 9. Outro(s), especifique

56 Método laboratorial
☐ 1. MPX PCR (positivo para Mpox poxvirus - especifico PCR)
☐ 2. Sorologia
☐ 3. Ortho PCR (positivo para orthopoxvirus PCR)
☐ 4. Sanger
☐ 5. Sequenciamento
☐ 6. Next Generation Sequencing (NGS)
☐ 7. Outro, especifique

57 Resultado do exame laboratorial
☐ 1. Detectável ☐ 2. Inconclusivo/indeterminado ☐ 3. Não detectável ☐ 4. Pendente

58 Se detectável, valor do CT

59 Caracterização genômica ☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 9. Ignorado

60 Se caracterização genômica sim, clado
☐ 1. WA = clado da África Ocidental
☐ 2. CB = clado da Bacia do Congo
☐ 3. Outro, especifique

61 Se caracterização genômica sim, número de adesão

Resultados de agravos ou ordenar

62 Existe coleta de amostra laboratorial para diagnóstico complementar?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não

63 Data de coleta __/__/____

64 Deseja inserir resultados de diagnósticos complementares
☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 3. Aguardando resultados

65 Varicela/Herpes zoster
☐ 1. Confirmado clinicamente ☐ 2. Descartado clinicamente ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
☐ 4. Descartado laboratorialmente ☐ 5. Não realizado ☐ 6. Aguardando resultado

66 Herpes simples
☐ 1. Confirmado clinicamente ☐ 2. Descartado clinicamente ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
☐ 4. Descartado laboratorialmente ☐ 5. Não realizado ☐ 6. Aguardando resultado

67 Infecções bacterianas de pele
☐ 1. Confirmado clinicamente ☐ 2. Descartado clinicamente ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
☐ 4. Descartado laboratorialmente ☐ 5. Não realizado ☐ 6. Aguardando resultado

68 Sífilis primária ou secundária
☐ 1. Confirmado clinicamente ☐ 2. Descartado clinicamente ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
☐ 4. Descartado laboratorialmente ☐ 5. Não realizado ☐ 6. Aguardando resultado

69 Linfogranuloma venéreo
☐ 1. Confirmado clinicamente ☐ 2. Descartado clinicamente ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
☐ 4. Descartado laboratorialmente ☐ 5. Não realizado ☐ 6. Aguardando resultado

V001 25/06/2025

Página 1 de 3

ANEXO - Ficha de notificação de mpox

Resultado diagnóstico alternativo

70 Cancroide
- ☐ 1. Confirmado clinicamente
- ☐ 2. Descartado clinicamente
- ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
- ☐ 4. Descartado laboratorialmente
- ☐ 5. Não realizado
- ☐ 6. Aguardando resultado

71 Molusco contagioso (Poxvírus)
- ☐ 1. Confirmado clinicamente
- ☐ 2. Descartado clinicamente
- ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
- ☐ 4. Descartado laboratorialmente
- ☐ 5. Não realizado
- ☐ 6. Aguardando resultado

72 Infecção gonocócica disseminada
- ☐ 1. Confirmado clinicamente
- ☐ 2. Descartado clinicamente
- ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
- ☐ 4. Descartado laboratorialmente
- ☐ 5. Não realizado
- ☐ 6. Aguardando resultado

73 Granuloma inguinal
- ☐ 1. Confirmado clinicamente
- ☐ 2. Descartado clinicamente
- ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
- ☐ 4. Descartado laboratorialmente
- ☐ 5. Não realizado
- ☐ 6. Aguardando resultado

74 Reação alérgica
- ☐ 1. Confirmado clinicamente
- ☐ 2. Descartado clinicamente
- ☐ 3. Confirmado laboratorialmente
- ☐ 4. Descartado laboratorialmente
- ☐ 5. Não realizado
- ☐ 6. Aguardando resultado

75 Especifique quaisquer outras causas de erupção cutânea papular ou vesicular

Investigação de informação individuais

76 Comportamento sexual
- ☐ 1. Relações sexuais com homens
- ☐ 2. Relações sexuais com mulheres
- ☐ 3. Relações sexuais com homens e mulheres
- ☐ 7. Não se aplica

77 Parceiras múltiplas
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 7. Não se aplica
- ☐ 9. Ignorado

78 O paciente é imunossuprimido?
- ☐ 1. Sim - devido alguma doença. Descreva _____
- ☐ 2. Sim - devido a medicação
- ☐ 3. Sim - causa desconhecida
- ☐ 4. Não
- ☐ 9. Ignorado

79 O paciente é HIV positivo
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 9. Ignorado

80 Se paciente HIV positivo, contagem das células CD4

81 O paciente está com alguma IST ativa?
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 9. Ignorado

82 Qual(ais) IST(s)?
- ☐ 1. Clamídea
- ☐ 2. Gonorreia
- ☐ 3. Herpes genital
- ☐ 4. Cancro mole (cancroide)
- ☐ 5. Donovanose
- ☐ 6. Linfogranuloma venéreo (LGV)
- ☐ 7. Mycoplasma genitalium
- ☐ 8. Sífilis
- ☐ 9. HPV
- ☐ 10. Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV)
- ☐ 11. Trichomomas varginalis
- ☐ 12. Verruga genital
- ☐ 13. Doença inflamatória pélvica (DIP)
- ☐ 14. Outras, especifique: _____

83 Possui histórico de vacinação para Smallpox (varíola humana)?
- ☐ 1. Sim, devido a vacinação prévia não relacionada ao evento atual
- ☐ 2. Sim, pré-exposição profilática para o evento atual
- ☐ 3. Sim, pós-exposição profilática para o evento atual
- ☐ 4. Não
- ☐ 9. Ignorado

84 Data da vacina

Exposição provável

85 Houve exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, com caso provável ou confirmado de Mpox?
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 9. Ignorado

86 Data da exposição

87 Houve contato físico direto, incluindo sexual, com desconhecido/a (s) e ou parcerias múltiplas, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas?
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 9. Ignorado

88 Data do contato físico

89 Houve história de contato íntimo, incluindo sexual, com algum caso provável ou confirmado de Mpox, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas?
- ☐ 1. Sim
- ☐ 2. Não
- ☐ 9. Ignorado

90 Data do contato íntimo

91 País

92 Se ocorreu no Brasil, em qual UF?

93 Se ocorreu no Brasil, em qual município?

V0003 25/06/2023

ANEXO - Ficha de notificação de mpox

Exposição provável

94 Qual foi o local do contato com caso suspeito ou confirmado de Mpox?

☐ 1. Domicílio ☐ 4. Creche/Escola ☐ 7. Evento social com contato sexual
☐ 2. Vizinhança ☐ 5. Posto de saúde/Hospital ☐ 8. Outro, especifique: _____
☐ 3. Trabalho ☐ 6. Evento social sem contato sexual ☐ 9. Ignorado

95 Qual o nome do contato?

96 Qual o (DDD) telefone do contato? (__|__) __|__|__|__|__|__|__|__|__

97 Detalhamentos da exposição

98 O paciente viajou com os sintomas relatados?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 9. Ignorado

99 Houve contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes a caso provável ou confirmado de Mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 9. Ignorado

100 O paciente é trabalhador de saúde que não fez uso adequado de equipamento de proteção individual (EPI) com história de contato com caso provável ou confirmado de Mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas?
☐ **1. Sim** ☐ **2. Não** ☐ **9. Ignorado**

101 A doença em investigação tem relação com o trabalho?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não ☐ 3. Não se aplica ☐ 9. Ignorado

102 Nome da empresa/empregador

103 Forma provável de transmissão
☐ 1. Do animal para o homem
☐ 2. Transmissão via uso de drogas intravenosas e transfusão
☐ 3. Associado ao cuidado de saúde
☐ 4. Trasmissão vertical (mãe-filho)
☐ 5. Trasmissão em laboratório, devido a exposição profissional
☐ 6. Transmissão sexual
☐ 7. Contato com material contaminado (ex: roupas, lençois e objetos)
☐ 8. Desconhecida
☐ 9. Outra, especifique _____

104 Se transmitido do animal para o homem, com qual animal teve contato?
☐ 1. Pets: cão, gato
☐ 2. Pets roedores
☐ 3. Animal silvestre (excluindo roedor silvestre)
☐ 4. Roedor silvestre
☐ 5. Outro, especifique _____

105 O caso tem vínculo epidemiológio com caso provável ou confirmado de de Mpox?
☐ 1. Sim ☐ 2. Não

Classificação do caso

106 Classificação final
☐ 1. Confirmado (laboratorialmente) ☐ 2. Descartado ☐ 3. Provável
☐ 4. Suspeito ☐ 5. Perda de seguimento ☐ 6. Exclusão

107 Data de conclusão da investigação
__|__|_____

108 Evolução do caso
☐ 1. Óbito por Mpox ☐ 2. Cura ☐ 3. Óbito por outra causa ☐ 9. Ignorado

109 Data de evolução
__|__|_____

Informações complementares e observações

V003 25/06/2025

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA **SAÚDE**